

Geriatria e Demências - Avançada

Vamos começar a entender um tema avançado da geriatria que, embora não seja extremamente frequente nas provas, faz toda a diferença para quem busca atingir percentuais elevados nas seleções de residência médica. Estamos falando das **demências rapidamente progressivas**, tendo como protótipo a **doença de Creutzfeldt-Jakob**.

Para contextualizar, imagine o seguinte cenário clínico: paciente de 62 anos, previamente completamente independente e autônomo, que em apenas seis semanas desenvolve dificuldade de memória importante, esquecendo compromissos simples do dia a dia. A família percebe mudanças comportamentais marcantes, com alternância entre apatia e irritabilidade, além de desequilíbrio para caminhar. Nas últimas duas semanas desse quadro, o paciente evolui com fala lentificada, episódios de mioclonias nos membros superiores e piora acelerada da desorientação. Ao exame físico, apresenta ataxia, rigidez leve, marcha insegura e mioclonias que são desencadeadas por estímulos táteis ou sonoros.

A ressonância magnética desse paciente mostra algo bem característico: **hipersinal cortical em fitas** (ou "em ripas") e **sinal aumentado no núcleo caudado e putâmen** nas sequências DWI e FLAIR, que pegam difusão. O líquido foi coletado e veio negativo para infecções. O paciente evolui rapidamente para dependência funcional completa.

Pegadinha de prova: quando você vê um caso clínico com essa tríade - demência rapidamente progressiva, mioclonias e alteração específica na ressonância (núcleo caudado e putâmen em DWI/FLAIR) - você deve pensar imediatamente em doença priônica, especificamente **Creutzfeldt-Jakob**.

Esse tipo de questão já caiu na Santa Casa de BH em prova de R3. Veja outro exemplo clássico: paciente de 69 anos, branco, que iniciou quadro de déficit cognitivo e, nas semanas seguintes, evoluiu com ataxia de marcha e disfagia.

Observem a velocidade da evolução: em questão de semanas, o paciente que estava bem desenvolveu um quadro neurológico grave. Ao exame inicial, encontrava-se pouco cooperativo, hipervigil, hiperreflexivo globalmente e apresentava mioclonias - aqui novamente as **mioclonias** aparecem como sinal marcante.

A ressonância magnética mostrou hypersinal em T2 do núcleo caudado e putâmen. As provas hematológicas e infecciosas no sangue não apresentaram alterações. O líquido estava sem alterações, exceto pela presença da **proteína 14-3-3**, que é um marcador específico utilizado na investigação diagnóstica dessa doença. O eletroencefalograma apresentou **atividade trifásica periódica**, alteração que pode realmente acontecer nesse quadro. O paciente apresentou piora progressiva dos sintomas, evoluindo rapidamente com mutismo, rigidez global e rebaixamento do nível de consciência.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é o protótipo da doença priônica e representa a principal causa das demências rapidamente progressivas. Mas atenção: existem outras causas de demência rapidamente progressiva que você precisa conhecer para não cair em pegadinhas.

Vamos definir com precisão o que é uma **demência rapidamente progressiva**: trata-se de um declínio cognitivo que evolui de forma acelerada, em semanas a poucos meses, geralmente em menos de um ano. Algumas literaturas estendem esse período para até um a dois anos, mas o conceito mais aceito em provas é de seis meses até um ano. O paciente apresenta um comprometimento cognitivo marcado e desproporcional ao tempo de evolução.

As causas podem ser divididas em categorias: **neurodegenerativas, infecciosas, imunomediadas, metabólicas e tóxicas**. Entre as principais causas, destacam-se as neurodegenerativas, e dentro desse grupo, as **doenças priônicas** assumem papel de destaque. A doença de Creutzfeldt-Jakob é a principal representante das doenças priônicas, caracterizando-se por uma alteração na proteína priônica que gera neurodegeneração rápida e devastadora.

Outras causas neurodegenerativas incluem a **variante rapidamente progressiva da doença de Alzheimer** - sim, existe uma forma atípica de Alzheimer que evolui muito mais rápido que a forma clássica que estudamos. Também podemos ter formas rapidamente progressivas de **demência por corpúsculos de Lewy** e **demência frontotemporal**, mas a mais marcada e característica continua sendo a doença priônica.

Agora vamos destrinchar a **doença de Creutzfeldt-Jakob** especificamente. Ela é a doença priônica humana mais comum, embora ainda seja considerada rara, com incidência de apenas um a dois casos por milhão de pessoas por ano. A idade média de início é em torno de 62 anos - grave esse número, pois costuma aparecer nas questões.

Patogênese: todos nós temos uma proteína priônica normal em nosso organismo, sem qualquer deformidade ou anormalidade. O problema surge quando ocorre uma alteração conformacional da proteína, gerando uma forma anormal que passa a se acumular de forma excessiva no tecido nervoso. Esse acúmulo leva à destruição neuronal progressiva e, conseqüentemente, à neurodegeneração acelerada. É exatamente esse processo que ocasiona o quadro demencial característico.

Quais são os **principais sintomas** que você deve procurar ativamente no caso clínico? Em poucas semanas a meses, o paciente evolui com declínio cognitivo importante, alterações comportamentais significativas e, o sinal mais marcante que você deve gravar em negrito na sua mente: **mioclonias**. As alterações comportamentais incluem agitação, mudança importante do padrão habitual de comportamento, com o paciente ficando diferente do que sempre foi.

As **mioclonias** são o sinal patognomônico que aparece em praticamente todas as questões da prova. Elas vêm associadas a **sinais extrapiramidais** (rigidez, bradicinesia) e **ataxia**, que representa manifestação cerebelar. O paciente pode apresentar ataxia axial com instabilidade postural, ataxia de marcha e alteração da motilidade ocular. A disartria também pode estar presente por conta dessa alteração cerebelar, tanto com ataxia de membros superiores quanto inferiores.

Mnemônico para Creutzfeldt-Jakob: pense em "MIOCLO-DCJ" - MIOclonias + CLO (declínio cognitivo rápido) + DCJ (Doença de Creutzfeldt-Jakob). As mioclonias são tão características que, quando você as vê em um contexto de demência rapidamente progressiva, praticamente fecham o diagnóstico.

Marcadores diagnósticos importantes: a **proteína 14-3-3** no líquido é um marcador específico, embora não seja 100% sensível. A presença de **atividade trifásica periódica** no eletroencefalograma reforça o diagnóstico. Na ressonância, procure por **hipersinal cortical em fitas** e **sinal aumentado nos núcleos da base** (especialmente caudado e putâmen) nas sequências que avaliam difusão (DWI) e FLAIR.

A evolução é inexorável e rápida, o que torna o diagnóstico precoce importante principalmente para orientação familiar e para afastar causas tratáveis de demência rapidamente progressiva, como causas infecciosas, autoimunes ou metabólicas que podem mimetizar o quadro inicial.